

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE FLORECIMIENTO (FLOURISHING SCALE - FS)

Eje IV: Recursos y Bienestar • Evaluación Breve del Bienestar Psicológico Eudaimónico y Prosperidad Vital

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Florecimiento (Flourishing Scale - FS).
Nombre Original	Flourishing Scale (FS; Diener, Wirtz, Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishi & Biswas-Diener, 2010).
Autores Originales	Dr. Ed Diener, Ph.D. y colaboradores (University of Illinois / The Diener Institute, EE.UU.).
Adaptación Hispana	Checa, Perales y Espejo (2018); De la Fuente et al. (2017); España y Latinoamérica.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento y Recursos. Bienestar psicológico eudaimónico y autorrealización.
Tipo de Instrumento	Autoinforme unidimensional ultracorto de 8 reactivos con escala Likert de 7 puntos (1 a 7).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 14 años). Población general, clínica, laboral y educativa.
Tiempo de Administración	2 a 4 minutos en administración autoadministrada rápida.
Régimen de Licencia	Dominio público con citación obligatoria / Acceso libre sin restricciones comerciales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL CONSTRUCTO DE FLORECIMIENTO PSICOLÓGICO

La **Flourishing Scale (FS)** fue creada por Ed Diener y colaboradores (2010) dentro del paradigma de la Psicología Positiva para complementar las medidas tradicionales de bienestar subjetivo hedónico (como la satisfacción con la vida o el afecto positivo). El constructo de **floreimiento (flourishing)** sintetiza las teorías eudaimónicas más influyentes (Ryff, Deci & Ryan, Csikszentmihalyi):

- Visión Holística del Éxito Psicosocial:** Evalúa el éxito autopercebido en áreas vitales clave: relaciones interpersonales significativas, autoestima, sentido de propósito existencial, optimismo hacia el futuro y competencia percibida.
- Indicador de Capital Psicológico y Resiliencia:** Un individuo que “florece” no es simplemente alguien sin síntomas depresivos o ansiosos; dispone de un excedente de recursos cognitivos y vinculares que amortiguan activamente la vulnerabilidad ante eventos estresantes.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (8 REACTIVOS NUCLEARES)

Dimensión Eudaimónica	Ítem FS	Enunciado Operativo Evaluado en la Versión Española (Checa et al.)
1. Propósito y Significado	Ítem 1	Llevo una vida con sentido y con un propósito claro.
2. Relaciones Sociales	Ítem 2	Mis relaciones sociales son enriquecedoras y me proporcionan apoyo.
3. Compromiso e Interés	Ítem 3	Me implicó activamente y me intereso por mis actividades diarias.
4. Contribución al Bienestar	Ítem 4	Contribuyo activamente a la felicidad y al bienestar de los demás.
5. Competencia y Dominio	Ítem 5	Soy competente y capaz en las actividades que son importantes para mí.
6. Autoestima y Autovalía	Ítem 6	Soy una buena persona y vivo una vida virtuosa.
7. Optimismo Existencial	Ítem 7	Soy optimista respecto a mi futuro.
8. Respeto de los Demás	Ítem 8	Las personas respetan quién soy y lo que hago.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

Diversos estudios psicométricos en muestras hispanohablantes (Checa et al., 2018; Fonseca-Pedrero et al., 2021) ratifican su solidez métrica:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna	Alfa $\alpha = 0.88 - 0.92$	Excelente homogeneidad interna para una escala breve de solo 8 reactivos.
Estabilidad Temporal	Test-retest $r = 0.82$	Elevada estabilidad temporal comprobada en intervalos de 4 semanas.
Estructura Factorial	Unidimensional (CFA)	Confirmación de un factor general unificado (CFI = 0.98, RMSEA = 0.045).
Validez Convergente	$r = 0.65 - 0.74$	Alta convergencia con la SWLS (Diener), PWB de Ryff y autoestima de Rosenberg (RSES).
Validez Discriminante	$r = -0.52$ (PHQ-9)	Fuerte correlación inversa con sintomatología depresiva, apatía y anhedonia.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Opciones de Respuesta:** Escala Likert de 7 alternativas: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ligeramente en desacuerdo (3), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), Ligeramente de acuerdo (5), De acuerdo (6), Totalmente de acuerdo (7).
- **Cálculo Total Directo:** La escala no contiene ítems invertidos. Se suman los valores de los 8 reactivos para obtener la puntuación total:

$$\text{Puntuación Total FS} = \sum_{i=1}^8 \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 8 a 56 puntos})$$

- **Direccionalidad Clínica:** Puntuaciones elevadas reflejan una vivencia robusta de prosperidad psicológica y recursos adaptativos personales. Puntuaciones deprimidas indican languidez psicológica o vacío existencial.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN DEL BIENESTAR

Estratificación	Rango PD	Estado Psicológico	Manifestación Operativa y Recursos Adaptativos
Florecimiento Pleno	48 a 56 pts	Floreciente (Flourishing)	Alto propósito, relaciones enriquecedoras, optimismo y alta autoeficacia.
Bienestar Moderado	40 a 47 pts	Bienestar adecuado	Población general típica; recursos adaptativos suficientes sin plenitud destacada.
Languidez / Fragilidad	30 a 39 pts	Languideciente (Languishing)	Vivencia de estancamiento, relaciones empobrecidas o vacío vocacional.
Déficit Crítico	< 30 pts	Colapso eudaimónico	Severa desesperanza, aislamiento vincular y desvalorización personal profunda.

SIGNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE “LANGUIDEZ” (PUNTUACIÓN 30-39 PUNTOS):

Un individuo en zona de languidez (30 – 39 puntos) puede no cumplir criterios diagnósticos de depresión mayor según DSM-5, pero presenta una vulnerabilidad multiplicada por tres para desarrollar trastornos afectivos o distimia ante futuros estresores laborales o de pareja.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO TERAPÉUTICO PARA LA PROMOCIÓN DEL FLORECIMIENTO

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN BASADO EN EL PERFIL DE FLORECIMIENTO:

- **Paso 1 (Administración en Fase de Mantenimiento / Cierre):** Emplear la FS tras remitir los síntomas agudos (ansiedad o depresión) para verificar si el consultante ha transitado hacia la salud positiva.
- **Paso 2 (Desglose de Reactivos Deficitarios):**
 - Si fallan Ítems 1 y 3 (Propósito y Compromiso): Introducir clarificación de valores y compromiso en acción (Terapia de Aceptación y Compromiso).
 - Si fallan Ítems 2 y 4 (Relaciones y Contribución): Pautar entrenamiento en habilidades sociales y voluntariado o actividades comunitarias altruistas.
 - Si falla Ítem 5 (Competencia): Diseñar tareas escalonadas con autoeficacia medible (técnicas de maestría conductual).
- **Paso 3 (Prevención de Recaídas):** Una puntuación sostenida en la FS ≥ 48 puntos es el indicador psicométrico más potente de resiliencia y blindaje contra recaídas afectivas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN TRAS RECUPERACIÓN DE EPISODIO DEPRESIVO

Identificación: Varón de 37 años, comercial de empresa farmacéutica, dado de alta médica tras remisión sintomática de un Trastorno Depresivo Mayor (BDI-II = 5). Acude a consulta psicológica refiriendo que, aunque ya no llora ni siente angustia, su vida carece de rumbo y motivación ("no estoy triste, pero me siento apagado, como un robot").

Evaluación Psicométrica Inicial:

• **Puntuación Total FS = 26 / 56 puntos (Déficit Crítico / Languidez Severa).**

• Reactivos críticos: Ítem 1 (Vida con sentido) = 2/7; Ítem 2 (Relaciones enriquecedoras) = 3/7; Ítem 3 (Interés diario) = 2/7; Ítem 7 (Optimismo futuro) = 3/7.

Plan Terapéutico Eudaimónico: Se implementó Terapia de Bienestar (Well-Being Therapy de Fava) articulada con ACT. Se identificaron momentos cotidianos de disfrute bloqueados por rumiación, se renegoció el propósito vocacional orientándolo a proyectos formativos de mentoría de jóvenes empleados y se reanudaron encuentros semanales de ocio con amistades de la infancia.

Reevaluación a las 12 Semanas: La puntuación total de la FS ascendió a **50 / 56 puntos (Florecimiento Pleno)**. El paciente verbalizó un renovado entusiasmo por su profesión y consolidó un sólido blindaje anímico ante el estrés laboral.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

COLAPSO TOTAL (FS < 20 PTS):

Una puntuación inferior a 20 puntos con puntuación de 1 en los reactivos de propósito y futuro (ítems 1 y 7) obliga a descartar ideación autolítica activa inmediata mediante escalas específicas.

DISOCIACIÓN SÍNTOMA-FLORECIMIENTO:

Un paciente puede tener síntomas ansiosos leves (GAD-7 = 7) y al mismo tiempo puntuar muy alto en florecimiento (FS = 52); el florecimiento no exige la ausencia total de emociones aversivas.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. *Social Indicators Research*, 97(2), 143-156.
2. Checa, I., Perales, J., & Espejo, B. (2018). Propiedades psicométricas de la Escala de Florecimiento en una muestra española representativa. *Anales de Psicología*, 34(3), 560-567.
3. De la Fuente, J., et al. (2017). Psychometric properties of the Flourishing Scale in Spanish university students. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 15(3), 643-662.
4. Fonseca-Pedrero, E., et al. (2021). Evaluación del florecimiento psicológico en población general española. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 26(1), 35-46.